



PROTOCOLO DE EXODONCIA DE DIENTES DECIDUOS

Clínica Universitaria de Odontología

INDICACIONES

- Caries extensa no restaurable.
- Infecciones con absceso o celulitis no controlables con tratamiento conservador.
- Necrosis pulpar con imposibilidad de realizar pulpectomía.
- Dientes temporales retenidos que interfieren con erupción del permanente.
- Dientes temporales en infraoclusión severa o anquilosis.
- Razones ortodóncicas interceptivas (ej. erupción ectópica de caninos permanentes).
- Traumatismos con fractura radicular o movilidad patológica.

CONTRAINDICACIONES

- Niños con alteraciones sistémicas graves sin autorización médica previa.
- Infección local aguda no drenada (se recomienda primero control del proceso infeccioso).
- Alteraciones de coagulación o en tratamiento anticoagulante sin valoración previa.
- Dientes temporales cuya extracción pueda comprometer la guía de erupción y no se disponga de mantenedor de espacio adecuado.

MATERIAL Y PREPARACIÓN

- Material básico de cirugía menor: fórceps pediátricos, elevadores pequeños, curetas, jeringa carpule con agujas cortas.
- Anestesia local infiltrativa (incisivos y caninos) o troncular (molares).
- Aislamiento relativo con separadores (Optragate®), aspiración o gasas y control de la conducta.
- Profilaxis antibiótica solo en casos justificados (pacientes inmunocomprometidos o riesgo de endocarditis bacteriana).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1. **Exploración clínica y radiográfica** previa para comprobar morfología radicular y relación con el germen permanente.
2. **Anestesia local** adecuada (lidocaína 2% con epinefrina 1:100.000).
3. **Desprendimiento gingival** suave con periostotomo si es necesario.
4. **Luxación y extracción:**
 - **Incisivos y caninos:** luxación ligera con elevador pequeño, extracción con fórceps recto siguiendo el eje del diente. Riesgo menor de daño al germen permanente, pero se debe vigilar la erupción del sucesor.
 - **Molares:** luxación progresiva con elevador, extracción con fórceps curvo adaptado a la anatomía radicular (raíces divergentes). Precaución con el germen del premolar. Se debe de revisar la cavidad para descartar restos radiculares.
5. **Hemostasia** con compresión y gasa estéril, sutura solo si hay desgarramiento gingival o cavidad amplia.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

- Morder gasa compresiva 15–20 minutos.
- Dieta blanda y fría durante las primeras horas.
- Analgesia: paracetamol 10–15 mg/kg/8h o ibuprofeno 5–10 mg/kg/8h.
- Higiene oral con cepillado suave evitando la zona intervenida las primeras 24h.
- Antibiótico sólo si hay infección diseminada o factores de riesgo.
- Explicar a los padres/cuidadores la importancia de seguimiento y considerar mantenedor de espacio en caso de pérdida prematura.

SEGUIMIENTO

- Revisión a la semana para valorar cicatrización.
- Control radiográfico si hubo complicaciones o raíces fracturadas.
- Revisión periódica para evaluar espacio y erupción del sucesor permanente.
- Indicación de mantenedor de espacio según la edad, el diente extraído y el estado de la dentición.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Management of Dental Patients. *Pediatr Dent*. 2023;45(6):372-80.
2. European Academy of Paediatric Dentistry. Guidelines on the management of dental trauma in primary teeth. *Eur Arch Paediatr Dent*. 2023;24(1):1-15.
3. Coll JA, Vargas K, Marghalani AA, Chen CY, Dhar V. Impact of pulpectomy versus extraction of primary teeth on patient-centered outcomes: a systematic review. *Pediatr Dent*. 2024;46(2):120-8.
4. Algerban A, Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. Effect of extraction of primary canines on eruption of displaced maxillary canines: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2022;161(5):e211-21.
5. De Carvalho GG, Borges-Oliveira AC, Chisini LA, Correa MB, Goettems ML. Dental arch spatial changes after premature loss of first primary molars: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2023;23:311.
6. Ministerio de Sanidad. Guía de la Salud Oral Infantil. Madrid: SNS; 2023.
7. Ministerio de Sanidad. Guía Terapéutica Antimicrobiana en Odontología. Actualización 2024. Madrid: SNS; 2024.